

PROCÉDURE ÉTAPE PAR ÉTAPE

Obtenir le passage en catégorie B du corps des ambulanciers de la fonction publique hospitalière

Guide pratique à l'usage des organisations syndicales — juin 2026

Un changement de catégorie statutaire (de la catégorie C vers la catégorie B) dans la fonction publique hospitalière relève exclusivement de la voie réglementaire nationale : aucun établissement, aucune direction d'hôpital, ne peut l'accorder localement. La procédure mêle un circuit administratif formel (décret, avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière, avis du Conseil d'État) et un rapport de force politique, sans lequel le circuit administratif ne s'enclenche jamais spontanément. Les étapes ci-dessous combinent les deux dimensions, dans l'ordre où elles doivent être engagées.

ACTEURS CLÉS À CONNAÎTRE

Acteur	Rôle
DGOS — Direction générale de l'offre de soins (ministère de la Santé)	Rédige le projet de décret modifiant le statut particulier du corps ; pilote la concertation technique.
DGAFP — Direction générale de l'administration et de la fonction publique	Arbitre la cohérence avec les autres catégories B de la fonction publique. Point de blocage fréquent.
Ministère du Budget (Bercy)	Donne un avis sur le coût pour la masse salariale hospitalière — souvent décisif.
CSFPH — Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière	Instance paritaire dont l'avis est obligatoire (mais consultatif) avant toute modification statutaire.
Conseil d'État	Avis obligatoire sur le projet de décret avant publication.

LES ÉTAPES

ÉTAPE 1 — Constituer un dossier technique solide

Préalable à toute démarche

Qui agit : Organisations syndicales locales (intersyndicale CGT/SUD)

Objectif : Disposer d'un dossier chiffré et juridiquement référencé, prêt à être mobilisé dès qu'une fenêtre s'ouvre

Fait

Reprendre et compléter la note déjà rédigée : écart entre le référentiel de formation du DEA et les missions réellement exercées, comparaison avec le précédent statutaire des aides-soignants (décret n° 2021-1257 du 29 septembre 2021), données chiffrées d'activité.

Ajouter si possible des indicateurs de sinistralité (incidents, agressions, accidents) sur les missions spécifiques (UHSI, psychiatrie sous contrainte, transports mortuaires).

Ce dossier ne doit pas être renvoyé à chaque relance : il doit être stabilisé une fois, puis simplement mis à jour.

ÉTAPE 2 — Relayer la demande vers les fédérations syndicales nationales

Étape la plus structurante

Qui agit : Intersyndicale locale → CGT Santé Action Sociale, SUD Santé Sociaux (niveau national)

Objectif : Faire porter le dossier par les organisations qui siègent effectivement au CSFPH

*En Cours
cgt + sud*

Une intersyndicale d'établissement, seule, ne siège pas au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière : seules les fédérations nationales y sont représentées.

Demander formellement aux fédérations d'inscrire la révision du statut du corps des ambulanciers à leur feuille de route revendicative et de la porter dans les instances nationales.

Sans ce relais, la lettre adressée à la Ministre reste un signal isolé, facilement classé sans suite.

ÉTAPE 3 — Mutualiser la démarche avec d'autres établissements

Construire un rapport de force national

Qui agit : Intersyndicales d'autres CHU (Angers, Tours, Lyon, etc.)

Objectif : Démontrer que la demande n'est pas un cas isolé mais une revendication de filière

*En Cours
chu
Montpellier
Chu Tours
Chu Angers
Lyon?
+
Aflash smur
de France*

Contactez les intersyndicales des CHU déjà identifiés comme comparables, pour une démarche écrite commune ou simultanée auprès du ministère.

Un dossier porté par plusieurs CHU pèse considérablement plus lourd dans l'arbitrage DGOS/DGAFF qu'une saisine unique.

Objectif concret : obtenir plusieurs lettres de saisine synchronisées, avec un argumentaire commun, dans une fenêtre de temps resserrée.

ÉTAPE 4 — Activer un relais politique local et parlementaire

En parallèle du canal administratif

Qui agit : Parlementaires de la circonscription concernée

Objectif : Créer une pression politique complémentaire au canal purement administratif

*Fait
PS + LFI +
DROITE =
Haute
Garonne
+
Maire de
Toulouse*

Sollicitez les députés et sénateurs des circonscriptions concernées pour qu'ils déposent des questions écrites ou orales au gouvernement sur le sujet.

Une question parlementaire oblige le ministère à formuler une réponse écrite publique, ce qui crée une trace officielle et un point d'appui pour la suite.

Ce levier est gratuit et rapide à activer ; il ne remplace pas la voie syndicale mais la renforce.

ÉTAPE 5 — Rechercher un véhicule de négociation déjà ouvert

Maximiser les chances d'aboutir

Qui agit : Fédérations nationales, en lien avec la DGOS

Objectif : Accrocher la revendication à une négociation existante plutôt que d'en ouvrir une nouvelle

A revoir avec AFASH si dossier en cours

Vérifier s'il existe une négociation salariale ou statutaire en cours dans la fonction publique hospitalière (clause de revoyure, conférence sociale, nouvelle séquence post-Ségur) à laquelle la révision du statut des ambulanciers pourrait être rattachée.

Historiquement, les révisions catégorielles abouties (cas des aides-soignants en 2021) sont nées d'un accord-cadre négocié globalement, et non d'une demande sectorielle isolée.

Une demande qui s'inscrit dans un cadre de négociation déjà ouvert progresse presque toujours plus vite qu'une démarche autonome.

ÉTAPE 6 — Saisine officielle de la Ministre et des services compétents

Formalisation écrite

Qui agit : Fédérations nationales (de préférence) ou intersyndicale, avec copie large

Objectif : Obtenir l'inscription formelle du sujet à l'agenda de la DGOS

Ministre de la santé + ministre de l'intérieur alerté.

Envoyer le courrier de saisine (déjà rédigé) à la Ministre de la Santé, avec copie systématique à la DGOS, la DGAFP, le CSFPH, la FHF et les fédérations nationales.

Demander explicitement l'ouverture d'une concertation technique et la saisine du Haut Conseil des professions paramédicales pour le volet formation (module de compétences complémentaire).

Conserver une preuve d'envoi (accusé de réception, recommandé) pour pouvoir relancer avec date certaine.

Saisine prête à envoyer

ÉTAPE 7 — Relancer méthodiquement, sans attendre une réponse spontanée

Éviter l'enlisement

Qui agit : Intersyndicale + fédérations

Objectif : Maintenir le dossier vivant dans l'agenda administratif

En cours

Programmer une relance écrite tous les deux à trois mois, avec mise à jour du dossier chiffré si de nouveaux éléments sont disponibles.

Solliciter un rendez-vous bilatéral avec le cabinet de la Ministre ou la DGOS, plutôt que de se limiter à l'échange de courriers.

L'absence de relance régulière est la cause la plus fréquente d'enlisement silencieux d'un dossier de ce type.

ÉTAPE 8 — Concertation technique avec la DGOS

Démarrage du circuit administratif

Qui agit : DGOS, fédérations nationales, DGAFP

Objectif : Construire conjointement les bases d'un projet de décret

Si la pression politique et syndicale aboutit à l'ouverture d'un dialogue technique, des réunions bilatérales DGOS/fédérations permettent de discuter du périmètre de la révision (statut, grille indiciaire, référentiel de formation).

C'est à ce stade que la proposition de module de compétences complémentaire (« Module Missions Hospitalières Spécifiques ») prend tout son sens : elle donne à la DGOS une base technique pour justifier la révision auprès de la DGAFP et de Bercy.

ÉTAPE 9 — Arbitrage interministériel

Étape généralement la plus longue

Qui agit : Ministère de la Santé, DGAFP, ministère du Budget

Objectif : Obtenir un accord sur le périmètre, le coût et le calendrier de la mesure

C'est l'étape où se décide réellement la suite : un avis favorable de la DGOS ne suffit pas si la DGAFP ou Bercy s'opposent au coût budgétaire de la mesure pour l'ensemble de la fonction publique hospitalière.

Le maintien de la pression syndicale et politique (étapes 3 et 4) est déterminant à ce stade, qui échappe largement à la vue directe des organisations syndicales.

ÉTAPE 10 — Rédaction des projets de décret

Mise en forme juridique

Qui agit : DGOS, en lien avec la DGAFP

Objectif : Disposer d'un texte modifiant le décret n° 2022-1658 du 26 décembre 2022 (statut) et fixant la nouvelle grille indiciaire

Sur le modèle de la révision des aides-soignants en 2021, la réforme prend généralement la forme de deux textes : un décret modifiant le statut particulier du corps (catégorie, grades), et un décret ou arrêté fixant le nouvel échelonnement indiciaire.

ÉTAPE 11 — Avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière (CSFPH)

Consultation obligatoire

Qui agit : CSFPH (représentants employeurs et organisations syndicales)

Objectif : Vote consultatif sur le ou les projets de décret

Le passage devant le CSFPH est une consultation obligatoire mais l'avis n'est que consultatif : un avis négatif des organisations syndicales n'empêche pas juridiquement la publication du texte, mais pèse politiquement.

Les fédérations doivent préparer leur intervention en amont du vote, en lien avec le dossier technique constitué à l'étape 1.

ÉTAPE 12 — Avis du Conseil d'État

Contrôle juridique

Qui agit : Section administrative du Conseil d'État

Objectif : Vérifier la conformité juridique du ou des projets de décret

Étape technique, sans marge de manœuvre syndicale directe, mais qui peut entraîner des ajustements rédactionnels avant publication.

ÉTAPE 13 — Publication au Journal officiel

Entrée en vigueur

Qui agit : Gouvernement

Objectif : Faire entrer en vigueur le nouveau statut et la nouvelle grille indiciaire

Comme pour les aides-soignants en 2021, le texte prévoit généralement des dispositions transitoires de reclassement (conservation de l'ancienneté, correspondance d'échelons) qu'il convient de vérifier attentivement à la publication.

CALENDRIER INDICATIF

Pour les précédents comparables (aides-soignants, techniciens hospitaliers), il s'est écoulé entre 18 et 36 mois entre l'ouverture du dossier et la publication au Journal officiel — et seulement lorsque la décision politique de revaloriser était déjà actée en amont (cas du Ségur de la santé). Sans négociation-cadre préexistante, le délai dépend presque entièrement de la capacité à maintenir la pression (étapes 2 à 7) jusqu'à l'ouverture effective du dialogue technique (étape 8).

POINT DE VIGILANCE

Le risque principal n'est pas le refus explicite de la demande, mais son **enlèvement silencieux** : un courrier de saisine reste très souvent sans réponse formelle, ou ne reçoit qu'un accusé de réception sans suite. La relance régulière (étape 7) et la mobilisation continue des relais syndicaux et politiques (étapes 2 à 4) sont donc aussi importantes que la qualité du dossier technique lui-même.